

NS

ROSANGELA MOREIRA MATSUMOTO

IDADE: 55a PESO: 74kg ALTURA: PROFISSÃO: téc enfermagem
 SINTOMAS:
 QUEIXAS: Dorco, trabalha escala noturna 12x36h /
 MEDICAMENTOS: HAS, Atenolol, nortriptilina (colúscel)
 Depoção hormonal / Refluxo.
 MÉDICO: Dr. Beatriz
 EXERCÍCIO FÍSICO: 2x semana (academia Hupin-bas / "saber mais")
 HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 8 ALMOÇO: 12:30 LANCHE: 18 JANTAR: 20
 HORA QUE DORME: 00:00 HORA QUE ACORDA: 7:40 - 8:30
 COCHILLO () SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM (X) NA SEMANA () NÃO FDS
 FUMO () SIM () NÃO / DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
 TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO:
 CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
 OVERLAP: MALLAMPATI: IV IAH: 26,7 L/h SPO2: 80% 2019/03
 PATOLOGIAS ASSOCIADAS:
 CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Disme septo / alergia
 HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA
 (N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA (N) OUTROS
 limite quadril /
 cirurgia nos 2x

PSG: CPAP: 7.0 cmH₂O em 2019 / sit

04/08 P= 7.0 (3.8 e/lv) desde 2019.
 23 IAH= (26.7 e/lv)

Dorme de manobra qdo sai do plantão
 a tarde dorme antes de ir p plantão

14/08 P= 7.0
 23 IAH= 0.6

M. de uso: 5h

Bem adapt. ↓ refluxo.

fua

04/09 P= 7.0 cmH₂O
 23 IAH= 0.4 e/lv

M. de uso: 6h 6'

fuga= 2.5 l/min.

Bem adapt., s/ queixas.

fua

09/10 P= 7.0 cmH₂O

23 IAH= 0.3 e/lv

M. de uso: 4h 43'

Bem adaptada, ainda dorme pouco (fua.)

10/11/23 P= 7 cmH₂O

IAH= 0.4 e/lv

m de uso= 6 horas - está de férias / dormindo mais

fuga= 1.9 l/min.

Bem adaptada.

20/12 P= 7 cmH₂O

23 IAH= 0.4 e/lv

M. de uso: 5h 31

Troco o filtro

fua claudia

26/03
24

$P = 7.0 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 0.3 \text{ e/ev}$
 $m. de uso = 5 \text{ hr}$
 $Fuga = 4.0 \text{ lpm}$

Bem adaptada.

fua.

06/06
24

$P = 7.0 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 0.4 \text{ e/ev}$
 $m. de uso: 5h33'$
 $Fuga = 1.5 \text{ lpm}$

Bem adaptado

fua

30/09/24

$P = 7.0 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 0.4 \text{ e/h}$
 $m. uso = 6h03 \text{ min.}$
 $fuga = 2.6 \text{ l/min}$

Bem adaptado

Silvia

03/02/25

$P = 7 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 0.4 \text{ e/h}$
 $m de uso: 4h50'$
 $fuga: 8,6 \text{ l/m}$

Bem adaptada

Natacha

15/05/25

$P = 7 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 0.5 \text{ e/h}$
 $m de uso: 4h16'$
 $fuga: 10,6 \text{ l/m}$

Bem adaptada

Natacha

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: ROSANGELA MOREIRA MATSUMOTO			
Sexo: F	Idade: 51 anos	Peso: 73 Kg	Altura: 1,52 m
IMC: 31,6	Data do Exame: 21/03/2019	Exame: 51655_01	
Médico solicitante: Dr Vanessa			

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 22:37:14 horas e encerrado às 05:40:03 horas, com latência para o sono de 13 minutos e latência para o sono REM de 122 minutos. O tempo total de sono foi de 288,0 minutos, com eficiência do sono de 68,2%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	3,1%	Até 5%
Estágio 2	67,9%	45 - 55%
Estágio 3	19,3%	> 15%
Sono REM	9,7%	20 - 25%
Eficiência do sono	68,2%	> 85%

No período total de sono permaneceu 134,5 minutos acordado e ocorreram 124 micro despertares (índice de 25,8 /hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 60 bpm, a maior de 70 bpm e a menor de 54 bpm.

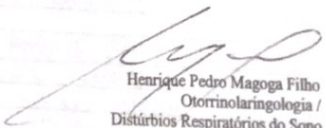
Foram identificados 0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora.

Ocorreram 128 eventos respiratórios, sendo 0 central, 128 obstrutivos e 0 misto. O índice de apnéia/hipopnéia total foi 26,7/hora, sendo 23,8 apnéia/hora e 2,9 hipopnéia/hora. O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 66,4/hora, sendo 62,1 apnéia/hora e 4,3 hipopnéia/hora.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 95%, sendo a saturação média de 95%, a maior de 99% e a mínima de 80%, permanecendo 4,8 minutos (1,1%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,0 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 126 dessaturações.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau moderada (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono reduzida.


Henrique Pedro Magoga Filho
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 129264